Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

3VARCIVBSB
3ª Vara Cível de Brasília

Número do processo: 0743422-38.2025.8.07.0001
Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IGNACIO DE SOUZA
REU: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de tutela de urgência e de indenização por danos morais, ajuizada por IGNACIO DE SOUZA em desfavor de UNIMED DO ESTADO RIO DE JANEIRO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos.

Narra a inicial (id 246467702) que o autor é pessoa idosa, com 88 anos de idade; que foi diagnosticado com câncer de próstata (CID10 C61) com metástase para os ossos; que seu médico prescreveu o medicamento NUBEQA (Darolutamida 300mg) para tratamento de sua doença; que esse medicamento, que é antineoplásico de uso oral, está registrado na ANVISA e consta no rol da ANS (RN 577/20/2023) como sendo de cobertura obrigatória; que ele também consta da DUT n. 64 como terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer de próstata; que, em situação análoga, o NatJus Nacional expediu diversas notas técnicas, dentre as quais a NT n. 185507, as quais atestam a eficácia na utilização do fármaco Darolutamida para o tratamento do câncer de próstata resistente à castração, situação idêntica à dos autos; que, não obstante tal situação, a ré não autorizou o tratamento prescrito ao autor pelo médico assistente; que o custo máximo de 1 caixa do medicamento é de R$ 20.750,29 e, segundo a prescrição médica e a bula do medicamento, a dosagem recomendada para o autor é de 2 comprimidos de 12 em 12 horas, isto é, 4 comprimidos por dia, o que resulta em 120 comprimidos por mês; que, assim, a prescrição é de 1 caixa do medicamento por mês, com previsão de duração do tratamento por cinco anos; que o autor não tem condições financeiras de arcar com os custos do tratamento e que a negativa do plano de saúde

Unimed FERJ é abusiva; que o custo anual do tratamento é de R$ 249.003,48; que a negativa da ré causou dano moral ao autor, que, há 3 meses tenta, sem sucesso, obter autorização para o tratamento prescrito por seu médico assistente; e que a Unimed Nacional foi incluída no polo passivo, com base na responsabilidade solidária entre cooperativas do sistema Unimed.

Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso concreto. Formula pedidos de exibição do contrato de adesão firmado com a ré, de prioridade de tramitação (em razão da idade, mais de 80 anos, e da doença grave) e de inversão do ônus da prova. Ao final, requer (i) a concessão de tutela de urgência para que a ré seja compelida a fornecer, de forma imediata e integral, a medicação NUBEQA (princípio ativo Darolutamida) 300mg com REV CT FR Plas PEAD OPCX120, por tempo indeterminado, nos termos do relatório médico, sob pena de multa diária; e, no mérito, (ii) a confirmação da tutela de urgência, com condenação definitiva das rés ao fornecimento da medicação NUBEQA (Darolutamida) 300mg com REV CT FR Plas PEAD OPCX120, por tempo indeterminado, nos termos do relatório médico, <u>até a finalização de todas as fases do tratamento</u>, sob pena de multa diária; (iii) a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00; e (iv), no caso de desembolso de qualquer quantia pelo autor para custeio do tratamento objeto dos autos, que as rés sejam condenadas à restituição da quantia, de forma simples e atualizada. Atribui à causa o valor de R$ 269.003,48. Junta documentos.

Decisão de id 246479412 deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as rés autorizassem e custeassem o fornecimento do medicamento NUBEQA (Darolutamida) 300mg com REV CT FR Plas PEAD OPCX120), conforme prescrição médica (id 246467720), no prazo de 5 dias corridos, sob pena de multa, bem como determinou a citação das rés.

Citada, a UNIMED NACIONAL apresentou a contestação de id 248757118. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não possuiria vínculo contratual direto com o autor, sendo apenas uma cooperativa central distinta da Unimed do Estado do Rio de Janeiro, responsável pelo plano. Ao final, requer o acolhimento da preliminar, com sua exclusão do polo passivo, ou, em caso de entendimento diverso, a improcedência dos pedidos iniciais. No caso de não acolhimento da preliminar e de procedência dos pedidos iniciais, requer que seja reconhecida sua responsabilidade apenas subsidiária. Junta documentos.

Petição do autor no id 248921730, informando o não cumprimento da liminar pela ré e juntando documentos.

Decisão de id 248927982 rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e ratificou as decisões de id 246479412 e 247969445, bem como determinou nova intimação da ré para cumprimento da liminar, sob pena de multa diária.

Citada, a UNIMED FERJ apresentou a contestação de id 249009791. Sustenta que a cobertura do tratamento pretendido seria obrigação do estado e que deveria ser realizado pelo SUS; que a medicação NUBEQA requerida pelo autor não atende à DUT n. 64 por inexistir na relação de terapia antineoplásica oral para o tratamento do autor; que o custeio do tratamento não é obrigatório, mesmo que seja a única alternativa de cura do paciente; que, no caso concreto, não há obrigatoriedade de fornecimento da Darolutamida (NUBEQA), tendo em vista não haver obrigação legal ou contratual de a ré fornecer medicamento fora das DUT; que a DUT 64 restringe a cobertura à situação de câncer de próstata resistente à castração não metastático, enquanto o autor apresenta quadro de câncer metastático sensível à castração; que a negativa da ré encontra amparo no art. 10, VI, da lei n. 9.656/1998, na DUT 64 da ANS e no relatório da CONITEC n. 912/2024; que, assim, o pedido de obrigação de fazer deve ser julgado improcedente; que não houve dano moral; que não há danos materiais indenizáveis; que não é possível o acolhimento de pedido de danos materiais futuros; e que os pedidos devem ser julgados improcedentes. Junta documentos.

Nova manifestação do autor no id 249595641, informando o descumprimento da liminar pela ré.

Decisão de id 249604009 determinou o bloqueio via BACENJUD do valor de R$ 20.750,29 em nome da 2ª ré, UNIMED NACIONAL.

Ofício de id 249710606 informou que, em agravo de instrumento interposto pela ré UNIMED FERJ (AI n. 0738185-26.2025.8.07.0000), foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo (id 249710607 - Pág. 10).

Petição da UNIMED NACIONAL no id 250793835, requerendo que o valor seja bloqueado da conta da corré e desbloqueado de sua conta.

Decisão de id 250849792 entendeu não haver nada a prover quanto ao requerimento da UNIMED NACIONAL e determinou a intimação do autor para comprovar, no prazo de 10 dias, a aquisição do medicamento.

Réplica no id 251777115.

Decisão de id 251806986 determinou a conclusão dos autos para julgamento.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Do julgamento antecipado da lide

O processo tem julgamento antecipado, uma vez que a questão suscitada no presente processo é prevalentemente de direito, o que atrai o disposto no art. 355, inciso I, do CPC. Nesse caso, o julgamento do processo no estado em que se encontra é medida que se impõe, não se fazendo necessária a dilação probatória.

A preliminar de ilegitimidade passiva já foi apreciada e rejeitada. Não há outras questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação.

Passo à análise do mérito.

DO MÉRITO

Da relação de consumo

A relação jurídica de direito material havida entre as partes sujeita-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, dada sua evidente caracterização como relação de consumo.

Nesse sentido, o STJ fixou a súmula 608, nos seguintes termos: *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."*

Assim, a legislação consumerista deve ser observada na interpretação e solução da presente lide, sem prejuízo de eventual diálogo desse microssistema com o estatuto civil comum.

Do ponto controvertido

A controvérsia dos autos diz respeito à obrigatoriedade ou não de cobertura para o tratamento indicado ao autor pelo médico assistente, bem como à ocorrência ou não de dano moral decorrente da negativa de cobertura.

Do direito

- Da taxatividade do rol da ANS

Alega a 1ª ré que o rol da ANS seria taxativo.

Com efeito, até pouco tempo atrás, debatia-se acerca do caráter taxativo do rol da ANS, consoante art. 2º da RN n. 465/2021, da ANS. Com a superveniência da Lei n. 14.454/2022, foi pacificada, naquele momento, tal controvérsia, tendo em vista ter sido assentada a natureza exemplificativa do referido rol da ANS, alterando o disposto na Lei n. 9.656/98, nos §§ 12 e 13 de seu art. 10, o qual passou a constar nos seguintes termos:

> *"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
>
> *(...)*
>
> *§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a* ***referência básica*** *para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.*
>
> *§ 13.* ***Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:***
>
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;* ***ou***
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."*

Questionada a constitucionalidade da Lei n. 14.454/2022, o STF, no julgamento da ADI n. 7.265, firmou a seguinte tese:

> *"1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta*

decisão.

2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente;

(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);

(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol da ANS;

(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou avaliação de tecnologias em saúde (ATS), necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e

(v) existência de registro na Anvisa.

3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente:

(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS;

(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo;

(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e

(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória."

Diante do exposto, restou decidido que é constitucional a escolha do legislador em obrigar planos a cobrirem tratamentos fora do rol da ANS, para garantia da efetividade do direito fundamental à saúde, mas que a lei n. 14.454/2022 definia requisitos amplos demais para a concessão de tratamentos fora do rol da ANS o que violaria a segurança jurídica e a previsibilidade do sistema de saúde privado. Diante disso, o STF definiu critérios mais estritos a serem seguidos, no caso de o tratamento prescrito não constar do rol da ANS como sendo de cobertura mínima obrigatória.

- *Da obrigatoriedade de cobertura do tratamento*

Apesar da longa exposição da ré acerca da taxatividade do rol da ANS, o que poderia levar a crer que o tratamento objeto dos autos não se encontra lá previsto, este não é o caso, já que o tratamento em questão se encontra expressamente previsto na DUT n. 64, que trata da *"terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer"*.

A 1ª ré, em sua contestação, alega a ausência de obrigatoriedade de cobertura do tratamento, uma vez que a situação em que se encontra o autor não estaria contemplada na DUT n. 64 e que estudos da CONITEC não atestariam a efetividade do tratamento com o medicamento em questão no caso apresentado pelo autor.

O tratamento com o medicamento objeto dos autos tem previsão na DUT n. 64, como já mencionado (id 246467730 - Pág. 73), o qual prevê a utilização do medicamento **Darolutamida** para tratamento de câncer de **próstata** em **duas situações**:

> 1) *"Tratamento de pacientes com câncer de próstata não metastático resistente à castração"*; ou
>
> 2) *"Em combinação com docetaxel, para o tratamento de pacientes com câncer de próstata metastático hormônio-sensível"*.

Conforme relatório médico de id 246467720 - Pág. 1, o autor possui *"adenocarcinoma usual de próstata Gleason 4 + 3 = 7, ISUP 3, PSAi 20,67"* e *"M1 sensível a castração de novo baixo volume e baixo risco".*

Ainda, segundo prescrição médica de id 246467720 - Pág. 2, consta menção a *"doença metastática para ossos considerando doença metastática sensível a deprivação androgênica de baixo volume e baixo risco."*

No id 246467720 - Pág. 3, consta que *"o melhor tratamento para o Sr. Ignácio é a associação de darolutamida a eligard em 1ª linha sensível a castração conforme dados do estudo ARANOTE."*

A 1ª ré argumenta que que a DUT 64 restringe a cobertura à situação de câncer de próstata não metastático resistente à castração. Contudo, esta é apenas a 1ª situação de cobertura, olvidando-se a ré que há previsão de cobertura para situação diversa, a saber, câncer de próstata metastático hormônio-sensível.

Assim, o argumento da ré de que o quadro do autor, de câncer metastático sensível à castração, não estaria previsto nas diretrizes de utilização do rol da ANS realmente não impressiona.

Com efeito, há previsão de cobertura para a situação em que se encontra o autor. Todavia, mesmo que assim não fosse, destaco que o não enquadramento a uma determinada DUT não se equipara à não previsão no rol da ANS.

Assim, estando o tratamento previsto no rol da ANS como sendo de cobertura mínima obrigatória, o fato de não haver perfeita coincidência da situação do paciente com aquela prevista na DUT não impede a cobertura do tratamento, tendo em vista que, como o nome já indica, trata-se de mera *"diretriz de utilização"*, diretriz esta que não é vinculativa.

De fato, o eventual não-atendimento aos critérios das DUT do Rol da ANS não é fundamento idôneo para a negativa de cobertura do procedimento requerido, uma vez que o medicamento em questão foi solicitado pelo médico assistente, a quem cabe definir o melhor tratamento para a doença, não competindo ao plano de saúde a análise quanto à sua real necessidade ou pertinência.

O medicamento prescrito possui registro ativo junto à Anvisa e o médico assistente prescreveu o uso do medicamento, fazendo constar expressamente sua necessidade pelo período estimado de 5 anos.

Embora a ré alegue a regularidade da exclusão de cobertura, é certo que o tratamento com o medicamento em questão não constitui terapia experimental e tampouco é destinado a tratamento de doença de cobertura não obrigatória, muito pelo contrário, já que se trata de tratamento de câncer, indiscutivelmente de cobertura obrigatória.

Ora, sendo obrigatória a cobertura da doença, não cabe ao plano de saúde apresentar limitações a seu tratamento, o qual somente pode ser decidido pelo médico assistente.

Ademais, destaco que o art. 17, parágrafo único, inciso VI, da RN 465/2021, da ANS, permite algumas exclusões assistenciais, mas o medicamento em questão não se enquadra em uma dessas permissões de

exclusão assistencial.

Desse modo, o acolhimento do pedido inicial de obrigação de fazer é medida que se impõe, sendo o caso, portanto, de confirmação da tutela de urgência já deferida.

Do pedido de indenização por dano moral

O autor também requereu a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da negativa indevida de cobertura e do sofrimento dela advindo.

A indenização por dano moral é prevista de forma expressa na Constituição Federal (art. 5º, V, CF), sendo que o dano moral, quando causado em pessoa natural, consiste em lesões aos atributos da personalidade do ofendido, ferindo seus sentimentos em razão de ofensa ao que lhe é mais caro, que é sua integridade física e psicológica, sua dignidade, autoestima, honra, credibilidade, bom nome profissional e tranquilidade, dentre outros.

Sabe-se que os elementos da responsabilidade civil e do dever de indenizar são ato ilícito, dano e nexo causal, conforme previsto nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. Assim, o direito do autor à indenização por dano moral depende da presença dos elementos legais autorizadores, razão pela qual passo à análise de tais requisitos.

O ato ilícito restou devidamente configurado, visto que, conforme já exposto anteriormente, houve negativa indevida de cobertura a tratamento de cobertura obrigatória, prescrito pelo médico assistente.

O dano moral também é inegável, tendo em vista a injustificável postergação do início do tratamento em mais de 3 meses, com grande risco para a saúde e a vida do autor, notadamente em razão de sua idade (88 anos) e de se tratar de doença grave (câncer metastático), em que cada momento de adiamento do início do tratamento implica a majoração do risco de não sucesso da terapia.

Além disso, trata-se de medicamento de alto custo a que o autor fazia jus, mas que não poderia adquirir por seus próprios meios, de modo que a negativa da ré causou no autor grande aflição, já que não podendo adquiri-lo, a não-utilização do medicamento prescrito implicaria risco de morte. Assim, a ré atingiu os direitos de personalidade do autor, notadamente seu direito à saúde, integridade física e psicológica, dignidade e tranquilidade.

O nexo causal entre a conduta ilícita da ré e o dano moral experimentado pelo autor é inegável.

Assim, presentes os requisitos, o pedido de indenização por dano moral deve ser deferido.

Resta fixar o valor suficiente à reparação do dano. Apesar de o artigo 944 do Código Civil estabelecer que a indenização se mede pela extensão do dano, conforme princípio da reparação integral, é difícil traduzir o abalo extrapatrimonial em quantitativo pecuniário.

Em razão da falta de parâmetros objetivos, portanto, para a fixação do quantum indenizatório, no caso de indenização por dano moral, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que se deve tomar em consideração a situação econômica das partes, de modo que a indenização não seja inócua, face à capacidade financeira dos envolvidos, e tampouco excessiva, a ponto de significar o enriquecimento sem causa do indenizado.

Ainda, na fixação da indenização no caso concreto, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva, bem como a repercussão do dano (art. 944, do Código Civil), assim como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, o valor indenizatório deve atender à sua dupla finalidade, de reparação e de punição/prevenção.

Dessa forma, e considerados tais elementos, tenho que o valor requerido pela parte autora é excessivo, sendo que o valor de R$ 10.000,00, se mostra proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, visto que tal valor não é suficientemente elevado para gerar enriquecimento indevido do autor e é compatível com o poder aquisitivo da parte ré e o grau de repercussão do dano.

Ressalte-se que o arbitramento de indenização por dano moral em valor inferior ao pedido não representa sucumbência recíproca quanto a este pedido, conforme entendimento deste TJDFT (vide acórdão de n. 1248963).

III. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, resolvo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: **(i)** CONFIRMAR a decisão de **id 246479412**, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés autorizassem e custeassem o fornecimento do medicamento NUBEQA (Darolutamida) 300mg com REV CT FR Plas PEAD OPCX120), conforme prescrição médica (id 246467720), no prazo de 5 dias corridos, contados de sua intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00

(vinte mil reais), posteriormente majorada pela decisão de **id 247969445** para o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e pela decisão de **id 248927982** para o valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), CONDENANDO as rés, de forma solidária, ao custeio do tratamento acima mencionado **pelo prazo previsto de 5 (cinco) anos**, conforme prescrição médica; e **(ii)** CONDENAR as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros pela SELIC, excluindo-se o IPCA, desde esta data, e juros de mora e correção monetária pela SELIC desde a data da última citação, respeitado o disposto no art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1º, ambos do Código Civil.

Condeno as rés, de forma solidária, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

Fiquem as partes desde já cientes de que a interposição de embargos de declaração eventualmente rejeitados por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material pode levar ao reconhecimento de expediente protelatório e atrair a incidência de multa, na forma do art. 1.023, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.

BRASÍLIA, DF, data e hora da assinatura digital.

GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ

Juíza de Direito